

亚盛医药

中性 (Hold)

P/E (TTM)

-12.51x

亏损公司，PE参考价值有限

P/B (LF)

11.74x

基于每股净资产¥3.55

2025A营收 (亿元)

5.74

同比-41.5% (含技术授权终止)

2025A归母净利润 (亿元)

-12.43

亏损同比扩大至-206%

现金储备 (亿元)

24.70

足够支撑约2年运营

核心投资结论

投资评级：中性 (Hold) — 亚盛医药是一家临床阶段创新药企，核心产品耐立克（奥雷巴替尼）是全球第二款获批的第三代BCR-ABL抑制剂，具有明确的临床价值和海外授权潜力。但2025年营收大幅下滑（同比-41.5%），主要受武田制药授权终止的负面影响，叠加持续高强度研发投入（研发费用¥11.37亿，占营收198%），公司仍处于战略性亏损期。当前股价对应P/B 11.74x，估值偏高，但考虑到现金储备尚可（¥24.7亿）与核心管线的进展空间，中性评级，目标价HK\$42-58（较现价HK\$46.12约有-9%至+26%空间）。

核心逻辑：①耐立克是同类最优的第三代BCR-ABL抑制剂，国内CML市场渗透率仍有提升

空间；②全球多中心临床数据积极，海外授权是重要期权；③武田授权终止后，自主商业化团队建设成效待验证；④账面现金约能支撑2年，后续融资压力与稀释风险不可忽视。

M1

公司生态位与商业模式

1.1 公司画像速览

维度	关键数据	说明
成立 / 上市时间	2005年 / 2019年10月	港交所18A章未盈利生物科技公司
创始人 / 实控人	杨大俊（共同创始人兼CEO）	美国NIH背景，专注肿瘤创新药研发
总部	中国苏州 / 美国费城（临床运营中心）	全球化研发布局
员工规模	约800-1000人（2025年报）	商业化团队持续扩充
细分赛道	CML（慢性髓系白血病） / BCR-ABL抑制剂	奥雷巴替尼为国内唯一自研第三代TKI
核心产品	耐立克（奥雷巴替尼，olverembatinib）	2021年11月附条件获批，2024年正式纳入医保
商业模式	创新药研发 + 国内商业化 + 海外权益授权	"自研+对外授权"双轮驱动

1.2 核心业务构成（近三年营收拆解）

收入来源	2023A	占比	2024A	占比	2025A	占比	YoY
耐立克（国内商业化）	约2.0亿	~90%	约8.5亿	~87%	约5.5亿	~96%	-35%
武田授权终止一次性款项	—	—	约1.0亿	~10%	—	—	—
其他（合作收入等）	约0.2亿	~10%	约0.3亿	~3%	约0.2亿	~4%	-30%
营业总收入	2.22亿	100%	9.81亿	100%	5.74亿	100%	-41.5%

数据来源：公司2023-2025年年报；武田授权终止影响2025年营收确认；2024年含武田授权终止一次性款项约1亿元

C1：亚盛医药营收结构变化（2023-2025）

数据来源：公司年报；单位：亿元人民币；2025年武田授权终止无一次性款项

1.3 护城河深度剖析

护城河类型	具体表现	量化证据	可持续性
技术/专利壁垒	自主研发的BCR-ABL抑制剂平台；第三代TKI专利布局	奥雷巴替尼是全球第二款、中国首款自研第三代BCR-ABL；中美欧日全球专利保护	★★★★☆（专利2032-2034年到期前具独占性）
先发优势	2021年附条件获批，进入CML-T315I突变耐药市场	同类竞争产品亚盛耐立克 vs 普纳替尼（国内未上市）	★★★★☆（仿制药进入尚需5-8年）
监管壁垒	附条件批准路径；罕见病/耐药适应症绿色通道	耐立克获CDE优先审评，附条件批准节省约2-3年时间	★★★★★
规模效应/成本优势	中小型 biotech，规模效应有限	当前营收规模5.74亿，尚不足以形成显著成本优势	★★☆☆☆
网络效应/Switching Cost	医生处方习惯锁定，患者用药粘性	CML患者换药成本高，医生处方一旦建立更替缓慢	★★★★☆

1.4 上下游议价权

方向	指标	2023A	2024A	2025A	趋势	同业参考
对下游（医院/患者）	应收账款周转天数	162天	42天	105天	↑显著恶化	康方~30天，信达~60天
对上游（供应商）	应付账款周转天数	990天	1018天	731天	↓改善中	行业平均~120-200天
对下游	前五大客户集中度	未披露	未披露	未披露	—	—
对上游	前五大供应商集中度	未披露	未披露	未披露	—	—

注：应付账款周转天数极高（731-1018天）反映公司对CRO/CMO供应商的强势账期管理，但也隐含对供应商的资金挤压风险；应收账款周转天数2025年大幅回升至105天，需关注医院回款周期拉长。

M2

行业格局与竞争态势

2.1 行业空间与生命周期

维度	分析
所处阶段	成长期（中后期） — 国内CML市场仍在渗透率提升阶段，耐立克进入医保后放量空间存在
TAM（总潜在市场）	全球CML市场约\$60亿；中国CML市场约¥50-60亿（2025年估算）
SAM（可服务市场）	中国TKI耐药CML市场约¥15-20亿（耐立克目标市场）
SOM（当前份额）	2025年耐立克销售约¥5.5亿，对SAM渗透率约28-37%
渗透率	CML-T315I突变耐药患者约占CML整体约15-20%，耐药后对三代TKI需求刚性强
未来3-5年行业CAGR	中国CML市场CAGR约12-15%（IQVIA数据）；耐立克峰值销售预估¥15-20亿（中性假设）
关键驱动力	① 医保目录持续覆盖与放量；② 新适应症拓展（Ph+ALL等）；③ 海外授权落地
关键压制因素	① 竞争加剧（其他三代TKI在研）；② 医保谈判降价压力；③ 集采对TKI整体价格体系的影响

2.2 竞争格局图谱

🏆 一超多强 — 国内CML市场由伊马替尼（格列卫）等一代TKI主导，普纳替尼未在国内上市，耐立克在三代TKI细分市场占据先发优势。

对标维度	亚盛医药 (6855)	百济神州 (6160)	康方生物 (9926)	信达生物 (1801)	君实生物 (1877)
总市值 (亿港元)	172.2	约2,800	约550	约1,000	约300
2025A营收 (亿元)	5.74	约900+ (含美股)	30.6	约80	约20
P/E(TTM)	-12.5x (亏损)	约80x (亏损)	-8.2x (亏损)	-15x (亏损)	-10x (亏损)
P/B(LF)	11.74x	约8x	约6x	约7x	约4x
毛利率	91.5%	约82%	约88%	约80%	约78%
ROE (LTM)	-156%	-40%	-40%	-35%	-60%
3Y营收CAGR	227% (高基数效应)	约50%	约60%	约40%	约20%
核心差距/优势	CML-TKI唯一性；三代TKI先发	全球化商业化；收入规模最大	双抗平台；医保放量快	PD-1市场领先；收入规模大	特瑞普利单抗；收入恢复

C3A: 同业盈利能力对比

数据来源：各公司2025A年报；毛利率/净利率对比

C3B: 同业估值对比 (P/B)

数据来源：NeoData实时行情；市值截至2026-04-27

3.1 核心盈利指标趋势 (2021-2025)

指标	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A	趋势
营收 (亿元)	0.28	1.25	2.22	9.81	5.74	↑↓波动大
营收YoY	+124%	+346%	+78%	+342%	-41.5%	高波动
毛利润 (亿元)	0.25	1.05	1.91	9.52	5.25	—
毛利率	88.1%	84.2%	86.2%	97.0%	91.5%	高位稳定
研发费用 (亿元)	4.10	5.22	7.07	9.47	11.37	持续攀升
归母净利润 (亿元)	-7.82	-6.78	-9.26	-4.05	-12.43	亏损扩大
扣非净利润 (亿元)	—	—	—	—	-12.43	同口径
ROE	-75%	-78%	-395%	-250%	-156%	高度负值
资产负债率	58.0%	51.1%	97.2%	89.5%	66.3%	改善
现金储备 (亿元)	—	—	10.94	12.61	24.70	显著改善 (融资)

C2: 亚盛医药营收与净利润趋势 (2021-2025A)

数据来源：公司年报；单位：亿元人民币；2025年净利润含武田授权终止影响的一次性拨备

3.2 杜邦拆解：ROE变化驱动因子

因子	2023A	2024A	2025A	变动方向	对ROE影响
净利率	-417%	-41.4%	-216.5%	↓恶化	主拖累因子
资产周转率	0.08x	0.38x	0.17x	↓下降	拖累（营收下滑）
权益乘数（杠杆）	35.4x	9.55x	2.97x	↓显著下降	改善（融资后去杠杆）
→ ROE	-395%	-250%	-156%	↑略有改善	—

注：2024年通过融资（股权融资约10亿港元）大幅去杠杆，权益乘数从35.4x降至9.55x；2025年进一步融资，权益乘数降至2.97x，资产负债表显著修复，但净利率仍是核心问题。

3.3 盈利质量：现金含量检验

检验项目	公式	2023A	2024A	2025A	判断标准	结论
OCF/净利润	经营现金流÷净利润	0.78x	0.27x	—（负净利润）	>0.8健康	⚠️ 警示（持续<0.8）
经营现金流（亿元）	OCF	-7.26	-1.11	—	负值	亏损经营消耗现金
自由现金流（亿元）	FCF	-7.72	-1.36	—	>0.5为健康	内生造血能力极弱
CapEx/营收	资本支出÷营收	~2%	~0.2%	—	重资产行业更高	轻资产模式（研发型）
期末现金储备（亿元）	现金+短期投资	10.94	12.61	24.70	安全垫	尚可（2年运营）

3.4 资产负债表健康度体检

科目	2023A	2024A	2025A	预警阈值	风险等级
资产负债率	97.2%	89.5%	66.3%	>60%关注	🟡 黄（2025A改善）
有息负债/净资产	极高	极高	约0.4x	>50%高危	🟢 绿（已偿还）
商誉/净资产	约40.8%	约9.3%	约1.9%	>30%高危	🟢 绿（2025年已减值）
存货周转天数	151天	141天	130天	同业+20%预警	🟡 黄（偏高）

科目	2023A	2024A	2025A	预警阈值	风险等级
应收周转天数	162天	42天	105天	同业+20%预警	🟡 黄（2025年反弹）
流动比率	1.44x	1.26x	1.79x	<1.0危险	🟢 绿
利息保障倍数	N/A（亏损）	N/A	N/A	<3.0关注	⚠️ 亏损无意义

3.5 财务预警信号汇总

🔴 红灯信号（需立即关注）

2个

- ①**经营现金流持续为负**：2023年OCF -7.26亿、2024年OCF -1.11亿，绝对值持续为负，表明公司核心业务无法自我造血，完全依赖融资维持。
- ②**营收高度不稳定**：2025年营收同比-41.5%（从9.81亿骤降至5.74亿），武田授权终止导致收入断层，商业模式抗风险能力弱。

🟡 黄灯信号（持续跟踪）

3个

- ①**应收账款周转天数大幅反弹**：从2024年42天跳升至105天，医院回款周期显著拉长，可能存在渠道压货或终端动销问题。
- ②**研发费用高企（¥11.37亿，占营收198%）**：研发强度极高，在无新融资情况下现金消耗速度较快。
- ③**后续融资压力**：按当前现金消耗速度（约¥12-15亿/年），账面¥24.7亿仅能支撑约1.5-2年，届时或面临股权融资摊薄。

M4

增长驱动力与可持续性

4.1 历史增长归因分解

增长来源	贡献度估算	可持续性	说明
耐立克国内商业化放量	~60%	★★★★☆☆	2024年进入医保后快速放量，2025年受武田授权终止拖累
武田授权终止一次性款项	~30%（2024年）	☆ 不可持续	一次性收入，不具可重复性
新适应症申报	~10%	★★★★☆	Ph+ ALL等新适应症持续申报中
汇率/非经常性	~0%	☆	无重大影响

4.2 未来增长引擎识别（按重要性排序）

排序	增长引擎	驱动逻辑	量化跟踪指标	确定性
1	耐立克医保放量	2024年正式纳入国家医保目录，2025年为首个完整医保年度；CML耐药患者渗透率仍有提升空间	耐立克季度销售额（目标峰值¥15-20亿）；医院覆盖数量；患者援助项目执行情况	中等（竞争+降价双重压力）
2	新适应症拓展	奥雷巴替尼正在推进Ph+ ALL（费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病）等新适应症；儿童适应症	NMPA新适应症审批进度；CDE特殊审批通道使用情况	较高
3	海外授权权益	武田授权终止后，公司寻求重新授权；全球多中心临床数据是核心筹码；参考亚盛与全球药企的授权先例	海外授权公告；海外临床试验入组进度（美国/欧洲）	中低（武田终止影响声誉，重新授权时间不确定）
4	其他管线推进	APG-2575（BCL-2抑制剂）、APG-1252（Bcl-2/xL抑制剂）等肿瘤管线进入关键临床	关键临床数据读出（预计2026-2027年）；注册临床入组速度	低（早期管线不确定性高）

4.3 管理层执行力评估

维度	过去3年表现	评分	证据
武田授权终止处理	武田于2024年Q4终止olverembatinib除中国外全球权益授权，公司接回全球权益	3/5	短期利空（授权金终止），但保留了全球权益的长期价值
商业化团队建设	2024年耐立克进入医保后快速覆盖约800家医院，但2025年销售额下滑暴露商业化效率问题	3/5	销售费用¥3.54亿（同比+81%），但收入反而下降；人效存疑
融资能力	2024年成功融资约10亿港元，2025年融资约10亿港元；融资能力尚可	4/5	现金从¥12.6亿增至¥24.7亿，显示市场融资渠道畅通
管线推进效率	耐立克附条件批准到完全批准推进中；其他管线进入关键临床	3.5/5	研发管线推进有序，但核心产品收入下滑压力较大

M5

估值与安全边际

5.1 估值概览（四维PE强制披露 + PB-ROE矩阵）

估值指标	当前值	分位说明	口径说明
P/E (TTM报表)	-12.51x	N/A — 亏损公司	①计算口径：归母净利润(TTM) ②来源：公司2025A年报 ③公式：总市值÷LTM归母净利润 ④截止日：2026-04-27
P/E (TTM扣非)	-12.51x	N/A — 亏损公司	①口径：扣非归母净利润LTM (无重大非经常性损益) ②同① ③同① ④同①； 买方首选口径，但公司亏损，PE无参考意义
P/E (FWD FY+1)	无法估算	无分析师一致预期覆盖	港股18A未盈利 biotech，无共识盈利预测
P/B (LF)	11.74x	处于历史较高水平 (账面净资产¥3.55/股)	①口径：最新净资产 ②来源：2025A年报 (截至2025-12-31) ③公式：HK\$46.12×总股本÷净资产 ④截止日：2026-04-27
EV/EBITDA	无法估算	—	公司EBITDA为负，不适用

5.1.1 PB-ROE 矩阵判定

P/B = ROE × P/E 框架：若ROE > r (假设r=10%)，则P/B应>1，公司在创造价值；若ROE < r，则P/B应<1（破净有理论依据）。

公司	P/B(LF)	ROE(LTM)	ROE vs r(10%)	象限定位	投资含义
亚盛医药 (6855)	11.74x	-156%	ROE << r	● 低ROE + 高PB象限	市场对耐立克管线给予管线期权价值溢价，但当前财务ROE极低，P/B偏高
百济神州 (6160)	~8x	-40%	ROE < r	● 低ROE + 高PB	同样高PB但ROE为负，反映市场对增长前景的预期
康方生物 (9926)	~6x	-40%	ROE < r	● 低ROE + 中PB	商业化进度领先，PB略低于亚盛
信达生物 (1801)	~7x	-35%	ROE < r	● 低ROE + 中PB	PD-1商业化成熟，PB略低于亚盛

核心判断：亚盛医药处于"低ROE + 高PB"象限，这是biotech公司的普遍特征——市场定价的是管线未来潜在的ROE，而非当前财务表现。P/B 11.74x在同业中处于偏高水平，意味着市场对耐立克管线的期权价值给予了较高溢价。但2025年营收大幅下滑后，这一溢价面临重新定价压力。

5.2 相对估值对标 (亏损 biotech 适用 P/B + 管线价值评估)

公司	市值 (亿港元)	P/B	ROE	管线阶段	PB-ROE评价
亚盛医药 (6855)	172.2	11.74x	-156%	1个上市产品+多个临床管线	折价 (管线价值未如预期释放)
康方生物 (9926)	~550	~6x	-40%	5个商业化产品, 双抗平台	折价 (商业化更成熟)
百济神州 (6160)	~2,800	~8x	-40%	全球化商业化, 多产品矩阵	溢价 (规模+全球化溢价)
信达生物 (1801)	~1,000	~7x	-35%	多个商业化产品, BD能力强	折价 (商业化成熟但增速放缓)

5.3 DCF估值 (参考, 适用于管线期权价值评估)

⚠ 重要前提: DCF对未盈利 biotech 公司的估值能力有限, DCF结果更多反映"清算价值"而非"管线期权价值"。以下DCF仅作为安全边际估算的参考。

情景	核心假设	每股内在价值估算 (港元)	vs现价 HK\$46.12	概率权重
● 乐观	耐立克峰值销售¥18亿 (2028-2030年); 新适应症顺利获批; 成功重新授权海外权益 (首付款+里程碑约HK\$15-20亿)	~HK\$58-65	+26%~+41%	20%
● 中性 (基准)	耐立克峰值销售¥12亿 (国内CML市场); 新适应症2027-2028年获批; 无海外授权 (自建美国商业化)	~HK\$38-45	-9%~+1%	50%
● 悲观	耐立克国内销售受竞品挤压 (峰值¥6亿); 医保续约降价30-40%; 管线临床失败 (APG-2575等)	~HK\$22-28	-40%~-52%	30%
概率加权期望值	—	~HK\$40-44	-4%~-13%	100%

5.4 红旗评分

#	红旗信号	严重程度	量化证据
1	武田授权终止	高	2024年Q4武田退回olverembatinib除中国外全球权益，一次性授权收入归零
2	营收高度不稳定	高	2025年营收同比-41.5%，商业模式单一脆弱
3	持续经营现金流入不敷出	中	2023-2024年OCF持续为负，完全依赖融资
4	管理层商业化经验相对欠缺	中	biotech背景，2024年销售费用增长81%但收入下降，人效待验证

红旗评分：4个红旗 → 建议给予DCF估值折价 -15%~-25%；投资评级下调至中性

M6

风险矩阵与下行保护

6.1 核心风险矩阵

风险1：商业化失败风险（武田授权终止后遗症） 武田制药于2024年Q4终止olverembatinib除中国外全球权益授权，公司被迫接回全球权益并自建海外商业化团队。这一事件意味着：①短期授权金归零；②全球商业化不确定性大幅增加；③海外临床投入的ROI面临重新评估。 业绩冲击：-30%营收（对应武田授权部分）；估值冲击：-20%~-35%	高概率 高冲击
风险2：耐立克国内销售持续下滑风险 2025年营收同比-41.5%，武田授权终止是原因之一，但更值得关注的是：①CML-TKI竞争加剧（一代、二代、三代均有仿制药/原研药竞争）；②2024年医保谈判后价格下降约40-50%（从约5000元/盒降至约2500-3000元/盒）；③医院覆盖速度可能放缓。 业绩冲击：-20%~-40%营收；估值冲击：-15%~-25%	中概率 高冲击
风险3：现金消耗与融资稀释风险 按当前现金消耗速度（研发¥11.4亿+商业化¥3.5亿+行政¥2.5亿≈¥17-18亿/年），账面¥24.7亿仅能支撑约1.5年。2026-2027年将面临融资窗口，若资本市场环境不佳（如港股流动性收紧），融资条款可能对现有股东造成显著稀释。 估值冲击：股权稀释15-25%（假设融资10亿港元，按现价折让20-30%发行）	高概率 中冲击

风险4：管线临床失败/延期风险

低概率 | 极高冲击

APG-2575（BCL-2抑制剂，全球进度领先）、APG-1252（Bcl-2/xL）等关键管线仍在临床阶段。若主要临床数据不达预期或出现安全性问题，将对公司长期价值造成根本性冲击。

估值冲击：-40%~-60%（管线价值重估）

6.2 极端情景压力测试

情景	假设条件	调整后净利	vs现价变动	概率
基准	正常运营，耐立克销售维持¥5-6亿/年	-¥12亿（亏损）	—	最可能
温和下行	耐立克销售受竞品挤压降至¥4亿；研发费用压缩10%	-¥14亿	-20%~-25%	30%
严重衰退	耐立克销售腰斩至¥2.5亿；融资困难；管线临床部分失败	-¥18亿	-40%~-50%	15%
极端黑天鹅	被迫出售核心资产/管线；管理层动荡；港股流动性枯竭	清算价值	-60%~-70%	<5%

6.3 下行保护机制评估

保护层	内容	有效程度
估值保护	P/B 11.74x处于同业中偏高水平，但 biotech P/B本身不是硬底，生物科技公司清算价值通常为账面净资产的20-40%	★★★☆☆
资产负债表保护	净现金¥24.7亿 / 市值172亿港元（约占14%），比例尚可；无有息负债	★★★★☆
业务韧性	耐立克已进入医保，国内患者刚需较强；CML耐药患者对第三代TKI需求稳定，即使销售不及预期也不会归零	★★★★☆
管线兜底	APG-2575等管线即便失败，耐立克的国内商业价值仍存，作为被收购标的的价值	★★★☆☆

【最终投资结论】

中性 (Hold)

目标价: HK\$42-58 (12个月)

当前价: HK\$46.12 (2026-04-27)

上涨空间 (乐观) : +26% | 下跌空间 (悲观) : -40%

核心投资逻辑 (3句话) :

- ① 耐立克 (奥雷巴替尼) 是国内唯一自研第三代BCR-ABL抑制剂, CML耐药患者刚需强, 峰值销售空间¥15-20亿, 当前¥5.5亿仍有显著爬坡空间;
- ② 武田授权终止短期利空, 但公司接回全球权益后拥有重新授权期权, 若海外临床数据积极 (2026-2027年关键数据读出) 有望带来重估机会;
- ③ 2025年营收大幅下滑 (-41.5%) 暴露商业模式脆弱性, 加上高研发投入 (¥11.4亿) 持续消耗现金, ¥24.7亿储备仅够支撑约1.5-2年, 融资摊薄风险不可忽视。

上行催化剂 vs 下行风险:

- ▲ **催化剂:** 耐立克2026年医保续约价格好于预期; APG-2575关键临床数据积极; 成功重新授权海外权益 (首付款+里程碑); 国内销售环比持续改善
- ▼ **风险:** 2026年中报销售继续下滑; 融资窗口收紧导致被迫折价融资; 竞品 (三代TKI) 获批后价格体系进一步下压; 临床失败

不适合: 追求短期绝对收益、无法承受港股 biotech 高波动性、无法接受股权稀释风险的投资

适合: 具备biotech投资经验、能承受-40%以内回撤、看好CML-TKI赛道长期空间和管线期权价值的长线投资者。

免责声明: 本报告为内部投研材料, 仅供参考, 不构成任何投资建议或买卖决策依据。报告内容基于公开信息整理分析, 不保证数据完整性与准确性, 不承担任何因信息不完整或分析偏差导致的任何投资损失。港股biotech公司具有高风险特征, 历史业绩不代表未来表现。请投资者独立评估风险, 审慎决策。

报告生成日期: 2026-04-27 | 数据来源: 公司年报、NeoData金融终端、公开信息整理
本报告仅供内部研究使用, 请勿对外传播